CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche V - C - 14

Version 1.4.0

Du 01/09/2026

TECHNIQUES ET MATÉRIELS

Rédacteurs :
Daniel MEYRAN
Julien PAPOZ
Danis LARGER

Compressions thoraciques à une main

INDICATIONS

Enfant de moins de 5 ans (≤ 20 kg) et de plus de 1 an qui présente un arrêt cardiaque (Fiche IV-B-7) ou qui a perdu connaissance à la suite d'une obstruction complète des voies aériennes (Fiche IV-B-1).

JUSTIFICATION

Quand le cœur s'arrête de fonctionner, le sang ne circule plus et la distribution d'oxygène n'est plus assurée. La compression régulière du thorax rétablit une circulation artificielle. Ce débit est suffisant pour maintenir le cerveau et le cœur de la victime oxygénés, notamment pendant les quelques minutes nécessaires à la mise en œuvre du choc électrique externe.

La pression, exercée au milieu de la poitrine d'une victime allongée sur le dos, vie les cavités cardiaques et les poumons du sang qui s'y trouve, et le propulse vers les organes périphériques.

Lorsque la pression est relâchée, la poitrine revient à sa taille initiale, le sang est de nouveau aspiré et remplit le cœur et les poumons. Ce sang sera ensuite propulsé par la compression thoracique suivante.

Lors d'un arrêt cardiaque consécutif à une obstruction complète des voies aériennes, les compressions thoraciques facilitent l'expulsion du corps étranger en élevant la pression qui règne à l'intérieur du thorax (effet de piston).

MATÉRIEL

- Aucun matériel spécifique

RÉALISATION

- Placer l'enfant en position horizontale, sur le dos, sur un plan dur[1] (sol).
- Se placer à genoux au plus près de la victime.
- Dénuder la poitrine de l'enfant, dans la mesure du possible.
- Placer le talon d'une main au centre de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum (fig. 1);
- Relever les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes ;
- Réaliser des compressions thoraciques successives en enfonçant le thorax d'au moins un tiers de son épaisseur ou d'environ 5 cm avec une main[2] :
  - appuyer verticalement en verrouillant le coude (fig. 3),
  - maintenir une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute,
  - assurer un temps de compression égal au temps de relâchement,
  - entre chaque compression, laisser le thorax reprendre sa forme initiale sans pour cela décoller le talon de la main du thorax de la victime.

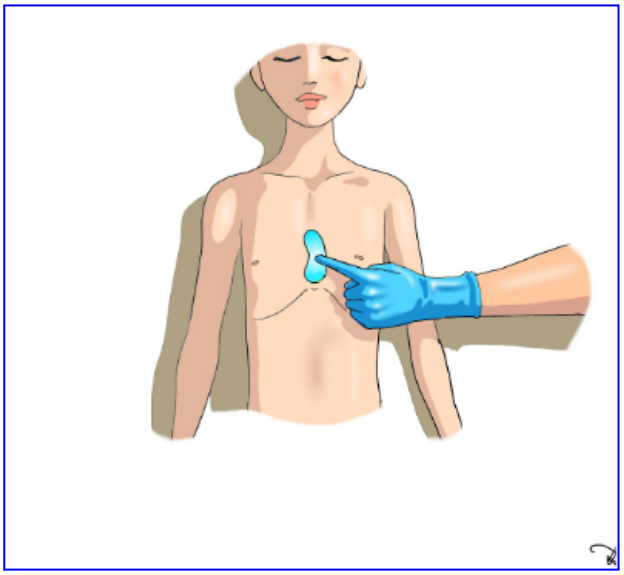


Figure 1 : zone d'appui

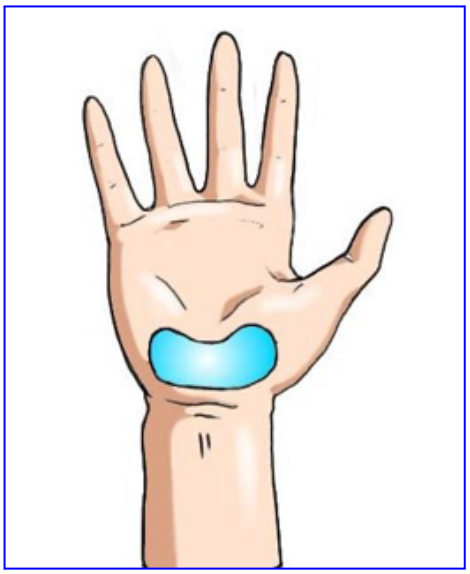


Figure 2 : talon de la main

Il est possible de changer la main qui effectue les compressions toutes les 2 minutes environ, voire plus fréquemment si le sauveteur perçoit des signes de fatigue.

Si la victime (enfant) est grande ou si le sauveteur est petit et n'a pas suffisamment de force, il peut être utile d'utiliser la même technique que chez l'adulte.

[1] La mise sur un plan dur de la victime ne doit pas retarder la mise en œuvre de la RCP.
[2] La compression doit dépasser un tiers de l'épaisseur du thorax lorsque cette technique est utilisée pour désobstruer les voies aériennes d'une victime suspectée d'obstruction par un corps étranger

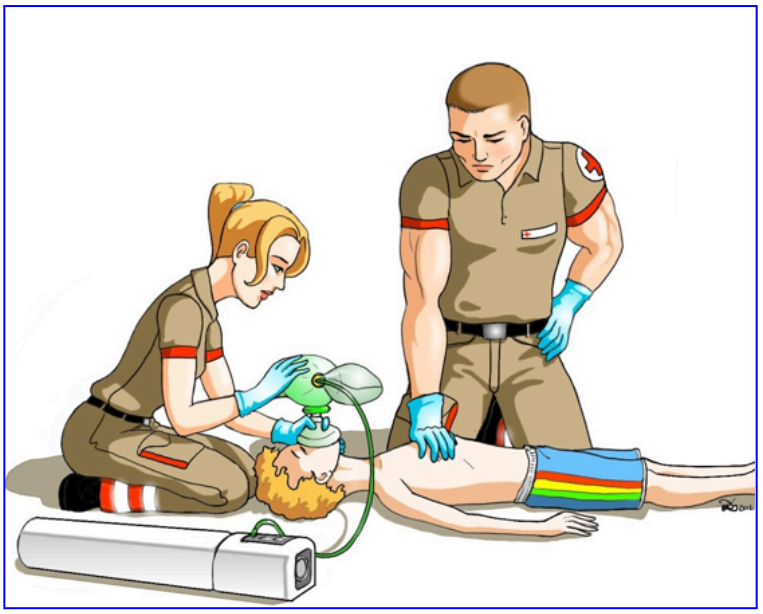


Figure 3 : compressions thoraciques à une main (enfant)

RISQUES & CONTRAINTES

Une mauvaise position de la main, une compression thoracique trop forte ou non verticale peut entraîner des lésions du thorax (fractures de côtes) et des poumons (contusion).

Ces risques ne doivent pas faire diminuer la vigueur des compressions thoraciques. La présence d'une ventilation agonique ne doit pas faire interrompre les compressions thoraciques.

ÉVALUATION

L'efficacité des manœuvres de réanimation s'évalue sur :

- la reprise d'une ventilation normale,
- la recoloration de la victime,
- la perception d'un pouls lors de chaque compression thoracique (à rechercher au niveau du pouls carotidien ou plutôt fémoral pour ne pas gêner la RCP).
- la récupération d'un corps étranger dans la bouche de la victime si l'AC est secondaire à une obstruction des voies aériennes par corps étranger.

Notes :